I. Description

Parmi les personnes de 65 ans et plus ou celles de 18 ans et plus à risque d'infection sévère à pneumocoque, l'indicateur est validé pour celles ayant reçu au moins une dose de vaccin conjugué contre le pneumocoque 20-valent (VPC20) ou 21-valent (VPC21) depuis la première inscription au remboursement (mars 2024).

II. Critères de ciblage

1. Population cible

« *Parmi les personnes de 65 ans et plus ou celles de 18 ans et plus à risque d'infection sévère à pneumocoque […]* » :

- Age ≥ 65 ans
  OU
- Age ≥ 18 ans
  ET
  - ALD active, avec un code CIM10 associé correspondant à l'un des items suivants :
    - ALD 2 – Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques
    - ALD 3 – Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques
    - ALD 5 – Insuffisance cardiaque, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires congénitales graves
    - ALD 6 – Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
    - ALD 7 – Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH
    - ALD 8 – Diabète de type 1 et diabète de type 2
    - ALD 9 – Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave
    - ALD 14 – Insuffisance respiratoire chronique grave
    - ALD 19 – Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique
    - ALD 21 – Panartérite noueuse, lupus, sclérodermie généralisée
    - ALD 22 – Polyarthrite rhumatoïde
    - ALD 24 – Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives
    - ALD 25 – Sclérose en plaques
    - ALD 27 – Spondylarthrite ankylosante grave
    - ALD 28 – Suites de transplantation d'organe
    - ALD 30 – Tumeur maligne

    OU
  - Au moins 4 délivrances de médicaments bronchodilatateurs (classe ATC = « **R03**** ») dans les 12 derniers mois
    OU
  - Au moins 1 délivrance de médicaments immunosuppresseurs (classe ATC = « **L04**** ») dans les 12 derniers mois

2. Critères d'exclusion

Pas de critère d'exclusion pour cet indicateur.

3. Critères de réalisation de l'acte de prévention

« *[…] ayant reçu au moins une dose de vaccin conjugué contre le pneumocoque 20-valent (VPC20) ou 21-valent (VPC21) depuis la première inscription au remboursement (mars 2024).* » :

- Délivrance d'une dose de vaccin pneumococcique conjugué 20-valent (VPC20) ou 21-valent (VPC21) (codes CIP = « **3400930247853** », « **3400930311462** », ou « **3400930311479** ») depuis mars 2024

III. Modalités de rémunération (FMT – Majoration Prévention)

À venir – les modalités de rémunération de cet indicateur seront précisées dans une version ultérieure de la fiche.

IV. Explications complémentaires

1. Argumentaire

L'objectif de cet indicateur est de permettre au médecin traitant de suivre la vaccination contre les infections à pneumocoque parmi ses patients éligibles à cette vaccination.

Conformément aux recommandations en vigueur, la vaccination antipneumococcique de l'adulte repose sur l'administration d'une dose unique de vaccin pneumococcique conjugué à haute valence, 20-valent (VPC20) ou 21-valent (VPC21), sans campagne de rattrapage ni revaccination systématique. Autrement dit, une personne éligible est considérée comme « à jour » dès lors qu'elle a reçu au moins une dose de VPC20 ou de VPC21. Les vaccins de valence inférieure (VPC13, VPC15) et le vaccin polyosidique non conjugué (VPP23) ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indicateur.

Le décompte débute à la date de première inscription au remboursement du VPC20 (mars 2024) : aucune délivrance antérieure ne peut donc valider l'indicateur.

Le ciblage de la population éligible s'appuie sur le calendrier vaccinal élaboré par le ministère chargé de la santé. Il s'agit de toutes les personnes de 65 ans et plus, ainsi que des personnes de 18 ans et plus à risque d'infection sévère à pneumocoque. Cette notion de « risque d'infection sévère à pneumocoque » repose sur la présence d'une affection de longue durée exposant à un risque accru d'infection invasive à pneumocoque, ou sur un recours régulier à des médicaments bronchodilatateurs (marqueur d'un asthme ou d'une bronchopneumopathie chronique obstructive), ou sur la délivrance de médicaments immunosuppresseurs.

2. Documents de référence

L'indicateur s'appuie sur les documents suivants :

- Calendrier des vaccinations : https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal

3. Limites

Ces indicateurs de prévention sont calculés à partir des données de remboursement de l'assurance maladie, qui ont l'avantage de couvrir l'ensemble de la population assurée, tous régimes confondus.

Cependant, par construction, elles ne retracent que les soins qui ont fait l'objet d'une facturation à l'assurance maladie.

Tout acte ou prestation réalisé hors de ce circuit ne sera pas pris en compte dans le calcul, et en particulier :

- Les soins réalisés à l'étranger ;
- Les soins prodigués au sein de certaines structures qui ne facturent pas à l'assurance maladie (médecine du travail, PMI, médecine scolaire ou universitaire, etc.) ;
- Certains soins sans codage spécifique prodigués lors d'un séjour en établissement (actes cliniques, certains actes techniques ou de biologie financés dans le cadre du séjour, médicaments délivrés par la pharmacie interne de l'établissement, etc.).

De même, les informations contenues dans le dossier médical du patient, y compris les résultats d'examen, et y compris les documents stockés dans son dossier médical partagé ou dans « Mon Espace Santé », ne seront pas prises en compte dans le calcul.

Par ailleurs, certains professionnels ou certaines structures de soins peuvent facturer les soins réalisés de façon différée (à une date ultérieure) : cela ne fausse pas la date de réalisation du soin, mais il faudra alors attendre que l'acte ait été effectivement remboursé pour qu'il puisse être pris en compte dans le calcul.

Enfin, indépendamment du délai de facturation de l'acte par le professionnel, il existe aussi un certain délai pour que l'information soit traitée et mise à disposition, et qu'elle puisse ainsi être prise en compte dans le calcul.

En pratique, pour toutes ces raisons, il peut y avoir un écart entre les données restituées et la situation réelle du patient à un instant donné. Pour cet indicateur, les principales situations susceptibles d'entrainer de tels écarts sont les suivantes :

a. Population cible

- Facteur de risque d'infection sévère à pneumocoque présent mais :
  - Sans que l'ALD correspondante n'ait été demandée/renseignée ;
    ET
    - Sans traitement médicamenteux ;
      OU
    - Médicaments délivrés par la pharmacie interne dans le cadre d'un séjour en établissement ;

b. Critères d'exclusion

- Pas de critère d'exclusion pour cet indicateur.

c. Critères de réalisation de l'acte de prévention

- Dose de vaccin conjugué administrée hors du circuit de facturation à l'assurance maladie (centre de vaccination, service de santé au travail, etc.) ;
- Dose de vaccin conjugué délivrée par la pharmacie interne dans le cadre d'un séjour en établissement de santé ou au sein d'un établissement médico-social (EHPAD notamment) ;

- Vaccination antérieure à mars 2024, ou réalisée avec un vaccin de valence inférieure (VPC13, VPC15) ou avec le vaccin polyosidique non conjugué (VPP23), non prise en compte par construction.

V. Précisions techniques

Source : SNIIRAM

Champ de la requête : tous régimes – patients ayant un médecin traitant

Profondeur de la requête par rapport à la date de référence de la photo :

- Pour définir la population cible : 12 mois pour les médicaments uniquement
- Pour les critères d'exclusion à prendre en compte : pas de critère d'exclusion
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour valider l'indicateur : première inscription au remboursement (mars 2024)
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour l'affichage : mars 2024

Composants utilisés pour la requête :

- ✓ DCIR → tables de consommation de soins de ville qui permet de repérer les actes et prestations générales (codes NGAP ou autres codes de facturation), les actes techniques (codes CCAM), les actes de biologie (codes NABM), ou la délivrances de médicament (codes CIP ou classes ATC) ; les soins facturés au cours d'un mois donné sont disponibles au début du mois suivant pour les assurés du régime général, et à la fin du mois suivant pour les assurés affiliés aux autres régimes (notamment MSA).
- ✓ IR_IMB_R → table du référentiel médicalisé qui permet d'identifier, en cas d'exonération du ticket modérateur (dont ALD), la pathologie précise (CIM10) associée.
- × PMSI → tables relatives aux soins et pathologies précises (CIM10) associées aux séjours réalisés dans les établissements de santé publics et privés ; les soins et séjours au cours d'une année sont disponibles à la fin du 1er semestre de l'année suivante.
- × SSU → données relatives aux formulaires d'exclusion des programmes nationaux de dépistages organisés des cancer ; ces formulaires sont fournis aux assurés pour qu'ils puissent signaler à l'assurance maladie un ou plusieurs motif(s) d'exclusion dont elle n'aurait pas connaissance.

VI. Acronymes

ALD : affections de longue durée

ATC : *anatomical therapeutic chemical* → système international de classification des médicaments, permettant de regrouper plusieurs médicaments par classe thérapeutique

CCAM : classification commune des actes médicaux

CIM10 : classification internationale des maladies, version 10

CIP : code identifiant de présentation → code permettant d'identifier un médicament précis

DCIR : datamart de consommation inter-régime

IR_IMB_R : table du référentiel médicalisé

MSA : mutuelle sociale agricole

NABM : nomenclature des actes de biologie médicale

NGAP : nomenclature générale des actes professionnels

PMSI : programme de médicalisation des systèmes d'information

PMI : protection maternelle et infantile → service départemental chargé d'assurer la protection sanitaire de la mère et de l'enfant

SNIIRAM : système national d'information inter-régime de l'assurance maladie